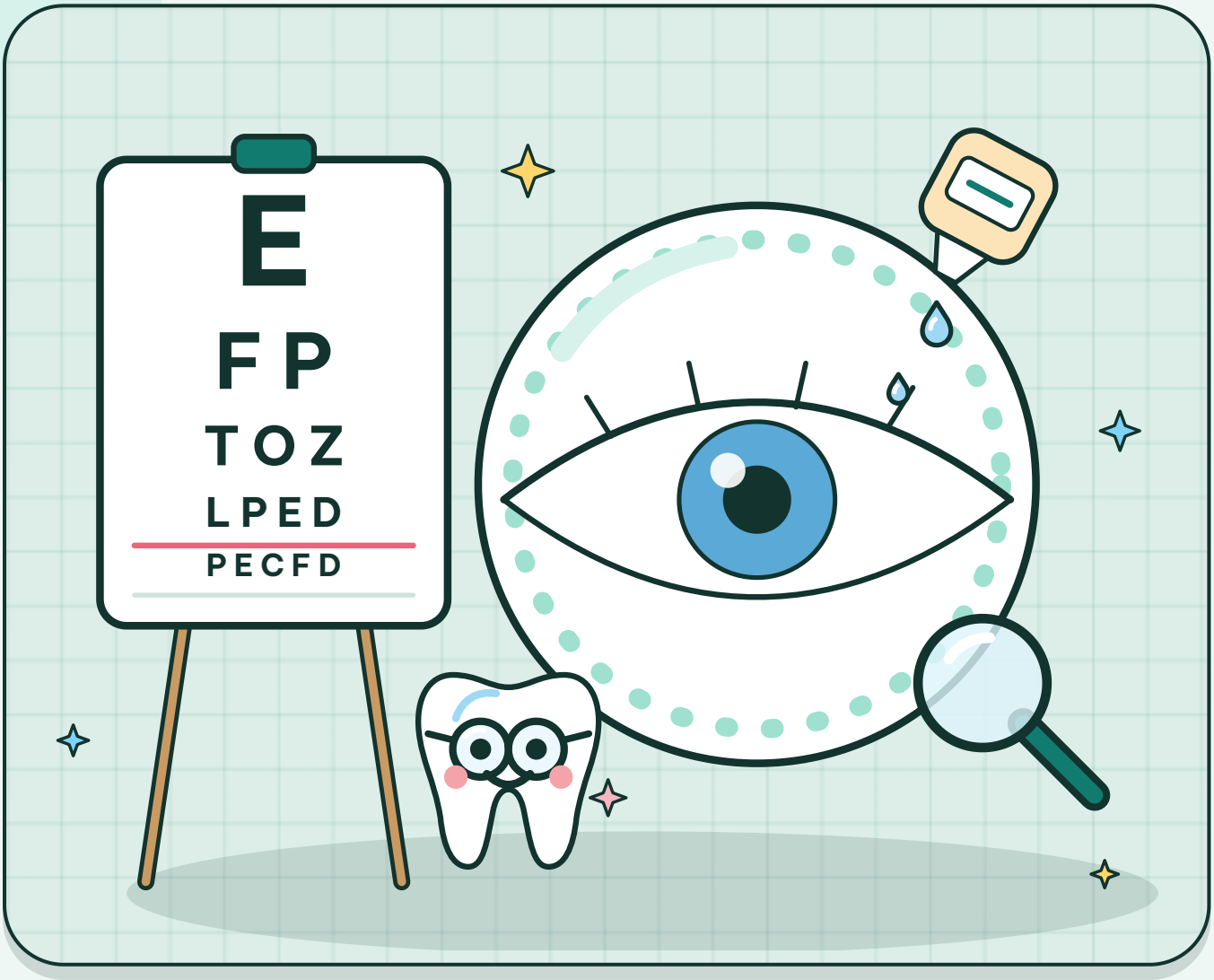
Ôn Luyện Nha Khoa
BỘ GIÁO TRÌNH ÔN TẬP

GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT

Mắt

5 bài · 30 hình minh hoạ · giải thích dễ hiểu, có mẹo nhớ

Đỏ mắt · Viêm kết mạc · Viêm loét giác mạc · Đục thủy tinh thể · Glaucoma



Tài liệu mang tính tham khảo

Mục lục

Giáo trình Mắt · 5 bài · 33 trang

BÀI 1 **Đỏ mắt: tiếp cận chẩn đoán và điều trị** 3

1. ĐẠI CƯƠNG 3
2. BA CÂU HỎI ĐỂ TIẾP CẬN ĐỎ MẮT 3
3. ĐỎ MẮT KHÔNG ĐAU, THỊ LỰC BÌNH THƯỜNG 4
4. ĐỎ MẮT CÓ ĐAU: NGHĨ TỚI NGUYÊN NHÂN NẶNG 5
5. BỆNH LÝ PHẦN PHỤ KHÁC 6

BÀI 2 **Viêm kết mạc** 8

1. GIẢI PHẪU, MÔ HỌC VÀ CHỨC NĂNG KẾT MẠC 8
2. ĐẠI CƯƠNG VÀ CHẨN ĐOÁN 9
3. TRIỆU CHỨNG 10
4. VIÊM KẾT MẠC DO VI KHUẨN 11
5. VIÊM KẾT MẠC DO VIRUS 12
6. VIÊM KẾT MẠC DỊ ỨNG 13
7. BẢNG PHÂN BIỆT NHANH 13

BÀI 3 **Viêm loét giác mạc** 14

1. GIẢI PHẪU GIÁC MẠC 14
2. ĐẠI CƯƠNG VÀ CƠ CHẾ BỆNH SINH 15
3. VIÊM LOÉT GIÁC MẠC DO NẤM 16
4. VIÊM LOÉT GIÁC MẠC DO VI KHUẨN 16
5. VIÊM LOÉT GIÁC MẠC DO HSV 17
6. CHẨN ĐOÁN 18
7. ĐIỀU TRỊ 19

BÀI 4 **Đục thủy tinh thể** 20

1. GIẢI PHẪU THỦY TINH THỂ 20
2. TỔNG QUAN VÀ YẾU TỐ NGUY CƠ 21
3. TRIỆU CHỨNG 21
4. CÁC HÌNH THÁI ĐỤC THỦY TINH THỂ 22
5. BIẾN CHỨNG 25
6. ĐIỀU TRỊ 26

BÀI 5 **Bệnh glaucoma** 27

1. SINH LÝ THỦY DỊCH 27
2. NHÃN ÁP 27
3. ĐẠI CƯƠNG VÀ PHÂN LOẠI 28
4. GLAUCOMA NGUYÊN PHÁT GÓC ĐÓNG 29
5. GLAUCOMA NGUYÊN PHÁT GÓC MỞ 31
6. GLAUCOMA BẨM SINH 32

Bấm vào tên bài hoặc tên mục để chuyển nhanh tới trang đó. Nội dung mỗi bài giống bản PDF từng bài trong app.

GIÁO TRÌNH MẮT · BÀI 1

BÀI 1 Đỏ mắt: tiếp cận chẩn đoán và điều trị

Biên soạn lại từ bài giảng 1. Red Eye - Diagnosis & Treatment.pdf (14 trang) · Giải thích dễ hiểu, kèm 2 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. ĐẠI CƯƠNG
2. BA CÂU HỎI ĐỂ TIẾP CẬN ĐỎ MẮT
3. ĐỎ MẮT KHÔNG ĐAU, THỊ LỰC BÌNH THƯỜNG
4. ĐỎ MẮT CÓ ĐAU: NGHĨ TỚI NGUYÊN NHÂN NẶNG
5. BỆNH LÝ PHẦN PHỤ KHÁC

Học xong bài này, bạn cần: nhận ra dấu hiệu cảnh báo của đỏ mắt; biết hướng tới nguyên nhân thường gặp; nắm nguyên tắc xử trí ban đầu và khi nào phải chuyển tuyến.

1. ĐẠI CƯƠNG

- Đỏ mắt là **một trong những triệu chứng nhãn khoa thường gặp nhất**.
- Nguyên nhân rất đa dạng: từ bệnh **lành tính, tự khỏi** (viêm kết mạc, xuất huyết dưới kết mạc) đến tình trạng **cấp cứu đe dọa thị lực** (viêm loét giác mạc, glôcôm góc đóng cấp).
- Việc của người thầy thuốc tuyến đầu không phải là chẩn đoán thật chi tiết, mà là **nhận diện dấu hiệu cảnh báo** để **xử trí ban đầu** và **chuyển tuyến kịp thời**.

Hiểu nhanh: mắt đỏ vì các mạch máu ở bề mặt nhãn cầu giãn ra hoặc vỡ ra. Câu hỏi quan trọng nhất luôn là: bệnh chỉ ở **bề mặt** (kết mạc, thường nhẹ) hay đã vào **bên trong** (giác mạc, mống mắt, nhãn áp, thường nặng)?

Hai kiểu đỏ cần phân biệt

Kiểu đỏ	Nhìn thấy	Gợi ý
Cương tụ kết mạc	Đỏ nhiều ở vùng cùng đồ, **nhạt dần khi về gần giác mạc**	Bệnh ở bề mặt: **viêm kết mạc**
Cương tụ rìa	Vòng đỏ sẫm **sát quanh rìa giác mạc**	Bệnh ở sâu: **viêm loét giác mạc, viêm mống mắt – thể mi, glôcôm góc đóng cấp**

2. BA CÂU HỎI ĐỂ TIẾP CẬN ĐỎ MẮT

Bài giảng chia đỏ mắt theo 3 câu hỏi, hỏi lần lượt:

- **Cấp hay mạn?** Mới xuất hiện hay đã kéo dài.
- **Một mắt hay hai mắt?** Bệnh toàn thân, dị ứng, nhiễm virus thường bị 2 mắt; chấn thương, bệnh khu trú thường 1 mắt.
- **Có đau hay không đau? Đau** là dấu hiệu nghĩ tới nguyên nhân **nặng hơn**.

Nhóm	Không đau	Đau
Mạn, 2 mắt	Co rút mi, lồi mắt, song thị: **bệnh mắt nội tiết** (Basedow)	Mỏi mắt, nóng rát, ngứa: **khô mắt** (viêm kết giác mạc khô)
Mạn, 1 mắt	**Hở mi** (nhắm mắt không kín): chuyển khám chuyên khoa **khẩn**	**Bất thường vị trí mi**: quặm, lật mi, lông xiêu

Nhóm	Không đau	Đau
Cấp, 2 mắt	Phù kết mạc, theo mùa, tiếp xúc dị nguyên: **viêm kết mạc dị ứng**	Sau hàn điện: **viêm giác mạc do tia**; hoặc tiết dịch trong, sợ sáng, co quắp mi: **viêm kết mạc virus**, chuyển chuyên khoa
Cấp, 1 mắt	Mắt lồi đập theo mạch: **dò động mạch cảnh – xoang hang** (chuyển khẩn); hoặc mảng máu đỏ xuất hiện đột ngột: **xuất huyết dưới kết mạc**	Nghi **dị vật, thủng nhãn cầu** hoặc **cơn glôcôm góc đóng cấp** (nhãn cầu **cứng như đá**): **cấp cứu**

Cảnh báo: đỏ mắt kèm **đau nhức, nhìn mờ, sợ ánh sáng, cương tụ rìa, đồng tử méo hoặc không co khi chiếu đèn, mủ tiền phòng, nhãn cầu cứng**, hoặc có **chấn thương, dị vật** → không tự điều trị kéo dài, **chuyển chuyên khoa mắt ngay**.

3. ĐỎ MẮT KHÔNG ĐAU, THỊ LỰC BÌNH THƯỜNG



Hình 1.1. Hai nguyên nhân đỏ mắt không đau thường gặp. Xuất huyết dưới kết mạc là một mảng máu khu trú; viêm kết mạc là đỏ lan tỏa do giãn mạch.

Viêm kết mạc

- **Do dị ứng: ngứa** là chính, chảy nước mắt, **phù kết mạc cả hai mắt**.
  - Điều trị: **ngưng tiếp xúc dị nguyên**; **kháng histamine** tại chỗ và toàn thân.
  - Dự phòng: **thuốc ổn định dưỡng bào** hoặc **kháng thụ thể H1**.
- **Do khô mắt:** cảm giác cộm, khô rát, đỏ nhẹ.
  - Điều trị bằng **nước mắt nhân tạo, gel bôi trơn** để tránh biến chứng **viêm giác mạc sợi**.
- **Do yếu tố cơ học:** bất thường mi (**lật mi, hở mi**) làm bề mặt mắt bị cọ xát, khô liên tục, tổn thương biểu mô.
  - Nhỏ thuốc chỉ đỡ tạm; muốn khỏi phải **phẫu thuật chỉnh hình mi**.
- **Do vi khuẩn** (Staphylococci, Streptococci):
  - Đỏ mắt, **dính mi khi ngủ dậy**, tiết dịch **mủ nhầy**, tạo **vảy vàng quanh mi**.
  - **Không đau, không nhìn mờ.**
  - Nếu xuất hiện **đau, sợ ánh sáng, co quắp mi** → nghĩ bệnh đã **ảnh hưởng giác mạc**.
  - Điều trị: **kháng sinh nhỏ mắt nhóm fluoroquinolones**.
- **Do virus** (chủ yếu **Adenovirus**, dễ **lây thành dịch**):
  - **Khởi phát ở một mắt rồi lan sang mắt còn lại.**
  - Tiết dịch **nhầy trong**, ngứa, cộm xốn, **nổi hạch trước tai**.
  - Thường **tự giới hạn trong khoảng 2 tuần**.

- Tránh tiếp xúc, **rửa tay sạch** để không lây; **nước mắt nhân tạo** giúp giảm triệu chứng.

Mẹo nhớ: Vi khuẩn → mủ, dính mi. Virus → nước trong + hạch trước tai, lây thành dịch. Dị ứng → ngứa, 2 mắt.

Xuất huyết dưới kết mạc

- **Cơ chế:** các mạch máu nhỏ dưới kết mạc có **thành mỏng, dễ vỡ**; máu tràn ra nằm dưới lớp kết mạc trong suốt.
- Xuất hiện **đột ngột**, **không đau**, **không ảnh hưởng thị lực**; thường sau **ho, hắt hơi mạnh, rặn** (nghiệm pháp **Valsalva** làm tăng áp lực tĩnh mạch).
- Yếu tố liên quan: **tăng huyết áp**, **rối loạn đông máu**, **dùng thuốc chống đông**.
- **Xử trí:**
  - **Đo huyết áp ngay** để loại trừ cơn tăng huyết áp cấp cứu.
  - Máu thường **tự hấp thu trong 2–4 tuần**, không cần nhỏ thuốc đặc hiệu.
  - Tư vấn bệnh nhân **khám tim mạch**.

Vì sao trông đáng sợ mà lại lành? Máu chỉ nằm ở lớp màng ngoài cùng, không vào trong nhãn cầu, nên mắt vẫn nhìn rõ và không đau. Điều cần lo không phải là con mắt mà là **huyết áp và đông máu** của bệnh nhân.

4. ĐỎ MẮT CÓ ĐAU: NGHĨ TỚI NGUYÊN NHÂN NẶNG



Hình 1.2. Bốn nguyên nhân đỏ mắt có đau cần nhận ra sớm. Viêm loét giác mạc và glôcôm góc đóng cấp là cấp cứu nhãn khoa.

Viêm loét giác mạc – CẤP CỨU NHÃN KHOA

- **Cơ năng:** cộm xốn, **cảm giác dị vật**, **đau lan lên hốc mắt**, **sợ ánh sáng**, chảy nước mắt, **nhìn mờ**.
- **Thực thể:** mi **co quắp**, sưng nề; **cương tụ rìa**; **tổn thương ở giác mạc** (ổ trắng đục); có thể có **mủ tiền phòng** (mức mủ trắng ở đáy tiền phòng).
- Chi tiết xem **Bài 3**.

Viêm củng mạc

- Thường gặp ở **phụ nữ 40–60 tuổi**, **có bệnh toàn thân** đi kèm; **50% bị cả 2 mắt**.
- Ba thể:
  - **Lan tỏa ≈ 40%**: nhẹ nhất.
  - **Dạng hạt (nốt) ≈ 45%**.
  - **Hoại tử**: hiếm, **đau +++**, viêm trầm trọng → **mỏng củng mạc, có thể thủng nhãn cầu**.
- **Cơ năng:** đau nhức, nhìn mờ, chảy nước mắt, sợ ánh sáng.
- **Thực thể:** kết mạc **cương tụ khu trú hoặc lan tỏa**.

Viêm mống mắt – thể mi

- **Cơ năng: đau, đỏ, sợ ánh sáng**.
- **Thực thể:**
  - **Cương tụ rìa**.
  - **Tủa mặt sau giác mạc** và fibrin rải rác ở nội mô giác mạc (các chấm trắng bám mặt trong giác mạc, như trong hình).
  - **Nhãn áp thường thấp** (có thể bình thường hoặc tăng).
  - **Phản ứng thể mi (+)**: ấn nhẹ vùng thể mi qua mi trên thấy đau.

Glôcôm góc đóng cấp – CẤP CỨU NHÃN KHOA

- **Cơ năng:** đau nhức dữ dội, đỏ, nhìn mờ; **nhìn đèn thấy quầng nhiều màu sắc**; **buồn nôn, nôn ói**.
- **Thực thể: cương tụ rìa**; giảm thị lực, **nhãn áp tăng rất cao** (sờ nhãn cầu **cứng như đá**); **tiền phòng nông**; **đồng tử giãn méo, phản xạ ánh sáng (–)**.
- Chi tiết xem **Bài 5**.

> **Cảnh báo:** bệnh nhân glôcôm cấp hay **nôn ói, đau đầu** nên dễ bị chẩn đoán nhầm là bệnh tiêu hóa hoặc thần kinh. Gặp người đau đầu, nôn mà **một mắt đỏ, nhìn mờ** → nhớ **sờ nhãn áp và nhìn đồng tử**.

So sánh nhanh 4 bệnh đỏ mắt có đau

Bệnh	Dấu hiệu "chìa khóa"
Viêm loét giác mạc	Ổ đục trên giác mạc, có thể mủ tiền phòng
Viêm củng mạc	Phụ nữ trung niên, bệnh toàn thân, đau nhức sâu
Viêm mống mắt – thể mi	Tủa mặt sau giác mạc, **nhãn áp thường thấp**
Glôcôm góc đóng cấp	Quầng màu, nôn ói, **nhãn áp rất cao**, đồng tử giãn méo

5. BỆNH LÝ PHẦN PHỤ KHÁC

- **Chắp, lẹo:** viêm nhiễm vi khuẩn cấp tại các **tuyến bã nhờn / mồ hôi ở bờ mi**.
  - Biểu hiện: **nốt sưng đỏ, đau khu trú** ở mi.
  - Điều trị: **chườm ấm + thuốc mỡ kháng sinh**.
- **Bất thường vị trí mi:**
  - **Quặm mi (entropion):** bờ mi **lộn vào trong** → lông mi cọ vào giác mạc.
  - **Lật mi (ectropion):** bờ mi **lộn ra ngoài** → hở mi, khô rát, chảy nước mắt.
  - Cả hai cần **phẫu thuật chỉnh hình mi**.

- **Dò động mạch cảnh – xoang hang:**
  - Mắt đỏ với **mạch máu kết mạc giãn to, ngoằn ngoèo**.
  - **Lồi mắt đập theo nhịp mạch**, nghe có **tiếng thổi trong hốc mắt**.
  - Yêu cầu **chuyển viện chụp MRI mạch máu khẩn cấp**.

> **Ghi nhớ cả bài:** đỏ mắt **không đau, nhìn rõ** → thường là bệnh bề mặt, điều trị được tại tuyến đầu. Đỏ mắt **có đau, nhìn mờ, cương tụ rìa** → bệnh ở sâu, là **cấp cứu**, chuyển chuyên khoa sớm.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ bài giảng 1. Red Eye - Diagnosis & Treatment.pdf. Hình minh hoạ lấy từ bài giảng, nhãn đã dịch sang tiếng Việt. Đối chiếu bài giảng gốc khi cần chi tiết.

BÀI 2 Viêm kết mạc

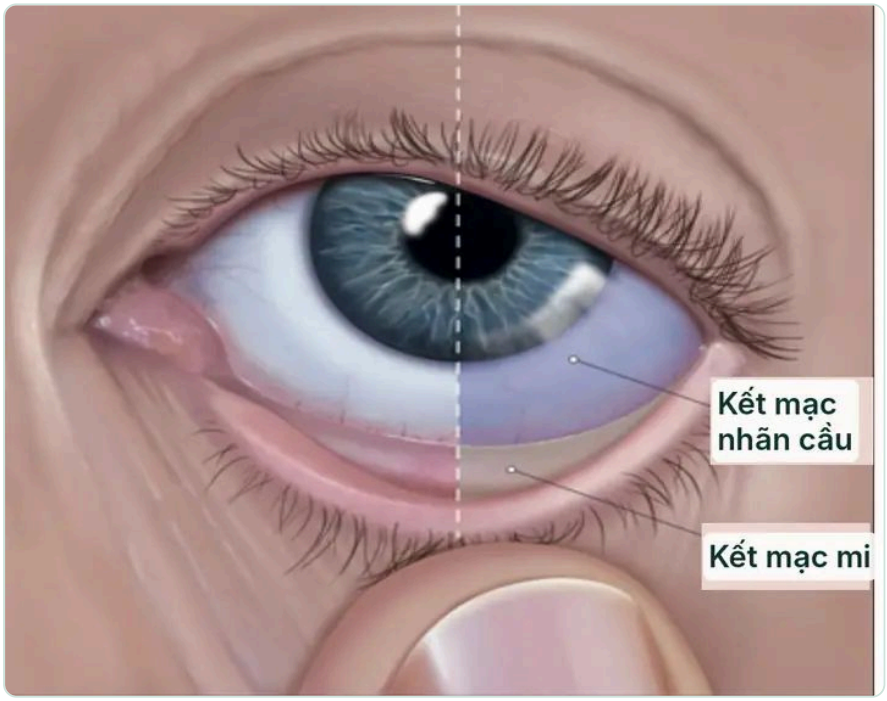
Biên soạn lại từ bài giảng 2. Conjunctivitis - Diagnosis & Treatment.pdf (20 trang) · Giải thích dễ hiểu, kèm 7 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. GIẢI PHẪU, MÔ HỌC VÀ CHỨC NĂNG KẾT MẠC
2. ĐẠI CƯƠNG VÀ CHẨN ĐOÁN
3. TRIỆU CHỨNG
4. VIÊM KẾT MẠC DO VI KHUẨN
5. VIÊM KẾT MẠC DO VIRUS
6. VIÊM KẾT MẠC DỊ ỨNG
7. BẢNG PHÂN BIỆT NHANH

Học xong bài này, bạn cần: nhận diện các tổn thương lâm sàng của kết mạc; chẩn đoán và điều trị theo từng nguyên nhân; biết cách phòng bệnh và tránh lây lan.

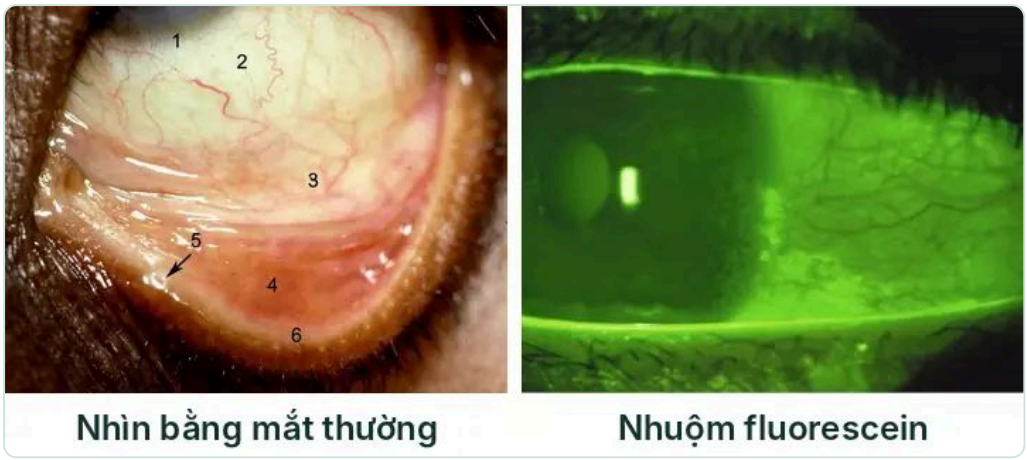
1. GIẢI PHẪU, MÔ HỌC VÀ CHỨC NĂNG KẾT MẠC

- Kết mạc là một **màng nhầy mỏng, trong suốt**, trải từ **rìa giác – củng mạc** đến **chỗ nối da – niêm của mi mắt**.
- Gồm 3 phần nối liền nhau:
  - **Kết mạc nhãn cầu:** phủ lên lòng trắng (củng mạc).
  - **Kết mạc cùng đồ:** chỗ gấp nếp giữa nhãn cầu và mi.
  - **Kết mạc mi:** lót mặt trong của mi mắt.



Hình 2.1. Kết mạc nhãn cầu phủ lòng trắng, kết mạc mi lót mặt trong mi; kéo mi dưới xuống sẽ thấy rõ cả hai.

Hiểu nhanh: hãy hình dung kết mạc như một **chiếc túi trong suốt** bọc mặt trước nhãn cầu rồi lật ngược lên lót mặt trong mi. Vì là túi kín, dịch tiết và vi trùng dễ ứ lại ở **cùng đồ**, và vì lớp màng trong suốt nên khi mạch máu bên dưới giãn ra, ta thấy ngay mắt đỏ.



Hình 2.2. Kết mạc khi quan sát bằng mắt thường (trái) và khi nhuộm fluorescein dưới ánh sáng xanh (phải).

- **Cấp máu: động mạch mi** và **động mạch mi trước**, bắt nguồn từ **động mạch lệ** và **động mạch mũi** của mi mắt.
- **Dẫn lưu tĩnh mạch:** tĩnh mạch kết mạc → **tĩnh mạch mi** → tĩnh mạch cơ.
- **Thần kinh chi phối:** nhánh **V1 và V2** của dây thần kinh sinh ba.

Mô học

- **Biểu mô: 5 lớp tế bào trụ lát tầng, không sừng hóa**.
  - Xen kẽ **tế bào đài** → tiết **chất nhầy**.
  - Khoảng gian bào chứa **kháng thể**.
- **Nhu mô: mô liên kết lỏng lẻo, giàu mạch máu**; chứa nhiều **tuyến lệ phụ Krause và Wolfring**.



Hình 2.3. Mô học kết mạc: lớp biểu mô có tế bào đài (trái) nằm trên lớp nhu mô lỏng lẻo, nhiều mạch máu (phải).

Chức năng

- **Bảo vệ:** hàng rào ngăn vi sinh vật xâm nhập bề mặt nhãn cầu.
- **Bôi trơn:** sản xuất **chất nhầy** và **nước mắt** (tuyến lệ phụ).
- **Bảo vệ miễn dịch:** giám sát và đáp ứng miễn dịch tại bề mặt nhãn cầu.

> **Vì sao kết mạc dễ viêm?** Nó tiếp xúc trực tiếp với môi trường (bụi, phấn hoa, vi trùng, tay dụi mắt) và có **nhu mô rất giàu mạch máu, tế bào miễn dịch**. Chỉ cần một kích thích nhỏ, mạch máu giãn ra và tế bào viêm kéo đến: đó chính là viêm kết mạc.

2. ĐẠI CƯƠNG VÀ CHẨN ĐOÁN

- Viêm kết mạc là **bệnh rất thường gặp** trong nhãn khoa.
- Bản chất: **giãn các mạch máu kết mạc** → tập trung **tế bào viêm và chất xuất tiết**.
- **Ba nguyên nhân chính: vi khuẩn, virus, dị ứng**.
- Theo thời gian: **cấp tính ≤ 3 tuần**, **mạn tính > 3 tuần**.
- **Chẩn đoán** dựa vào một hoặc nhiều yếu tố:
  - **Lâm sàng là chủ yếu.**
  - **Soi tươi, nhuộm Gram, Giemsa.**
  - **Nuôi cấy + kháng sinh đồ** (khi nặng, kéo dài, không đáp ứng điều trị).

3. TRIỆU CHỨNG

Cơ năng

- **Đỏ mắt, không đau, không giảm thị lực** – đây là "bộ ba" điển hình.
- Sưng nề mi; **ngứa, rát, nóng** trong mắt.
- Chảy nước mắt hoặc **chất tiết**.
- Nếu **biến chứng lên giác mạc**: **đau nhức, cộm xốn, cảm giác dị vật, mờ mắt**.

> **Lưu ý:** viêm kết mạc đơn thuần **không làm mờ mắt**. Khi bệnh nhân bắt đầu đau, sợ sáng, nhìn mờ là bệnh đã lan vào **giác mạc** – cần khám chuyên khoa.

Thực thể: chất tiết gợi ý nguyên nhân

Chất tiết	Gợi ý nguyên nhân
Dạng nước	**Virus** hoặc **dị ứng**
Dạng nhầy	**Khô mắt** hoặc **dị ứng mạn tính**
Dạng mủ	**Vi khuẩn**



Hình 2.4. Ba dạng chất tiết: nước trong, nhầy dai và mủ đặc (ở trẻ sơ sinh, mủ nhiều cần nghĩ tới lậu cầu).

Thực thể: các tổn thương trên kết mạc

- **Phù kết mạc:** kết mạc phồng mọng như bọng nước.
- **Sung huyết kết mạc:** mạch máu giãn, đỏ rực.
- **Phản ứng nang:** các hạt nhỏ, tròn, trong như hạt sương ở kết mạc mi – hay gặp trong **viêm do virus**.
- **Xuất huyết dưới kết mạc:** mảng máu đỏ tươi.



Hình 2.5. Phù kết mạc, sung huyết kết mạc, phản ứng nang và xuất huyết dưới kết mạc.

- **Phản ứng nhú:** các gai nhỏ, đỏ, có lõi mạch máu ở giữa, làm kết mạc mi sần như nhung – hay gặp trong **viêm do vi khuẩn và dị ứng**.
- **Màng kết mạc:** lớp màng trắng phủ trên kết mạc (màng giả bóc dễ, màng thật bóc chảy máu).
- **Sẹo kết mạc:** di chứng của viêm kéo dài.
- **Phản ứng hạch lympho:** sờ thấy **hạch trước tai**, hạch dưới hàm.



Hình 2.6. Phản ứng nhú, màng kết mạc, sẹo kết mạc và vị trí các hạch lympho vùng mắt.

Mẹo nhớ: nang → virus; nhú → vi khuẩn hoặc dị ứng; hạch trước tai → nghĩ ngay Adenovirus.

4. VIÊM KẾT MẠC DO VI KHUẨN

Triệu chứng cơ năng

- **Cấp tính, thường bị 2 mắt**: có thể 1 mắt bị trước, **1–2 ngày sau lan sang mắt còn lại**.
- **Chất tiết dạng mủ**, **dính mi khi thức dậy buổi sáng**.
- Có thể kèm triệu chứng toàn thân khi nhiễm **lậu cầu, não mô cầu**...

Triệu chứng thực thể (tùy mức độ nhiễm trùng)

- **Sưng nề mi** (rõ khi nhiễm **lậu cầu**).
- **Thường gặp phản ứng nhú**, ít gặp phản ứng nang.
- Có thể kèm **tổn thương biểu mô giác mạc**.
- Có thể có **màng giả** và **màng thật**.

Điều trị

- Bệnh **tự hồi phục dần sau 1–2 tuần**. Nếu điều trị đúng, **khỏi sau khoảng 1 tuần**, đồng thời **giảm tái phát và giảm lây nhiễm** trong cộng đồng.
- **Kháng sinh phổ rộng:** Gentamycin, Tobramycin, Ciprofloxacin, Ofloxacin...
  - **Thuốc nhỏ: 4–6 lần/ngày.**
  - **Thuốc mỡ: 1–2 lần/ngày, trước khi ngủ.**

> **Vì sao dùng thuốc mỡ buổi tối?** Thuốc mỡ lưu lâu trên mắt nhưng làm nhìn mờ, nên dùng lúc đi ngủ là vừa giữ thuốc suốt đêm, vừa không ảnh hưởng sinh hoạt.

5. VIÊM KẾT MẠC DO VIRUS

Adenovirus

- Có **4 thể**:
  - Viêm kết mạc **sốt – họng – hạch**.
  - Viêm **kết – giác mạc thành dịch**.
  - Viêm kết mạc có **phản ứng nang cấp không đặc hiệu**.
  - Viêm kết mạc **mạn**.
- Có thể biến chứng **viêm giác mạc chấm nông** (thường **sau 2 ngày**), **thâm nhiễm dưới biểu mô**.

Herpes simplex virus (HSV)

- **Nguyên phát** hoặc **thứ phát**.
- **Tương đối nhẹ**, **trừ ở trẻ sơ sinh**.
- Sang thương điển hình trên **da mi**, kèm viêm kết mạc, **viêm loét giác mạc**, viêm màng bồ đào... **Hiếm khi xảy ra đơn thuần.**
- **Đa số bị 1 mắt.**

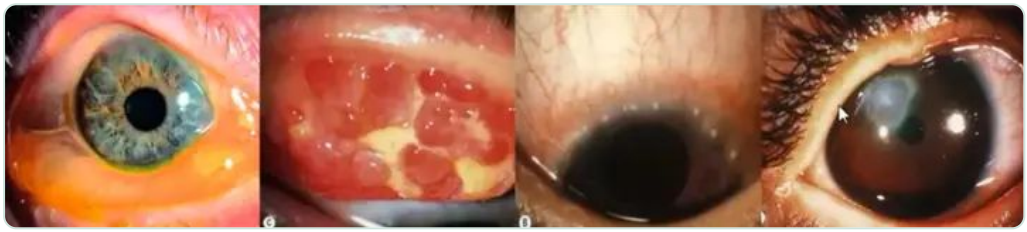
Điều trị viêm kết mạc do virus

- **Giữ vệ sinh mắt**, **tránh lây lan cộng đồng** (rửa tay, không dùng chung khăn).
- **Điều trị triệu chứng**, nâng cao sức đề kháng.
- **Kháng sinh chỉ dùng để ngừa bội nhiễm.**
- **Thuốc kháng virus không hiệu quả** (với viêm do Adenovirus).
- **Corticoid liều thấp:** hạn chế đáp ứng miễn dịch quá mức, nhưng **phải cân nhắc kỹ** khi dùng.

> **Vì sao không cho kháng sinh để "diệt" virus?** Kháng sinh không tác động lên virus; nó chỉ có ích khi lo **bội nhiễm vi khuẩn**. Bệnh do Adenovirus tự giới hạn, việc quan trọng nhất là **không để lây** cho người khác.

6. VIÊM KẾT MẠC DỊ ỨNG

- **Cơ năng: 2 mắt**, **ngứa** (triệu chứng nổi bật), đỏ, sưng, chảy nước mắt, **chất tiết trong**; có **tiền căn dị ứng**.
- **Thực thể:** sưng phù mi, phù kết mạc, **phản ứng nhú kết mạc**; có thể tổn thương giác mạc; **không có phản ứng hạch**.



Hình 2.7. Viêm kết mạc dị ứng: mi và kết mạc phù nề, kết mạc mi có nhiều nhú.

- **Điều trị:**
  - **Hạn chế tiếp xúc dị nguyên**; **chườm lạnh**.
  - **Tại chỗ:** nước mắt nhân tạo; **kháng histamin, co mạch, ổn định dưỡng bào**; corticoid.
  - **Toàn thân: kháng histamin uống**.

7. BẢNG PHÂN BIỆT NHANH

Đặc điểm	Vi khuẩn	Virus (Adenovirus)	Dị ứng
Số mắt	Thường 2 mắt (cách nhau 1–2 ngày)	Bắt đầu 1 mắt rồi lan	2 mắt
Triệu chứng nổi bật	Mủ, dính mi buổi sáng	Chảy nước, cộm, lây thành dịch	**Ngứa**
Chất tiết	Mủ	Nước	Nước trong / nhầy
Phản ứng	Nhú	**Nang**	Nhú
Hạch trước tai	Ít gặp	**Có**	**Không**
Điều trị chính	Kháng sinh phổ rộng	Vệ sinh, triệu chứng	Tránh dị nguyên, kháng histamin

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ bài giảng 2. Conjunctivitis - Diagnosis & Treatment.pdf. Hình minh hoạ lấy từ bài giảng, nhãn đã dịch sang tiếng Việt. Đối chiếu bài giảng gốc khi cần chi tiết.

GIÁO TRÌNH MẮT · BÀI 3

BÀI 3 Viêm loét giác mạc

Biên soạn lại từ bài giảng 3. Corneal Ulcer - Diagnosis & Treatment.pdf (19 trang) · Giải thích dễ hiểu, kèm 5 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. GIẢI PHẪU GIÁC MẠC
2. ĐẠI CƯƠNG VÀ CƠ CHẾ BỆNH SINH
3. VIÊM LOÉT GIÁC MẠC DO NẤM
4. VIÊM LOÉT GIÁC MẠC DO VI KHUẨN
5. VIÊM LOÉT GIÁC MẠC DO HSV
6. CHẨN ĐOÁN
7. ĐIỀU TRỊ

Học xong bài này, bạn cần: nêu được đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng của viêm loét giác mạc; chẩn đoán sơ bộ được tác nhân gây bệnh; nêu được các phương pháp điều trị viêm loét giác mạc nhiễm trùng.

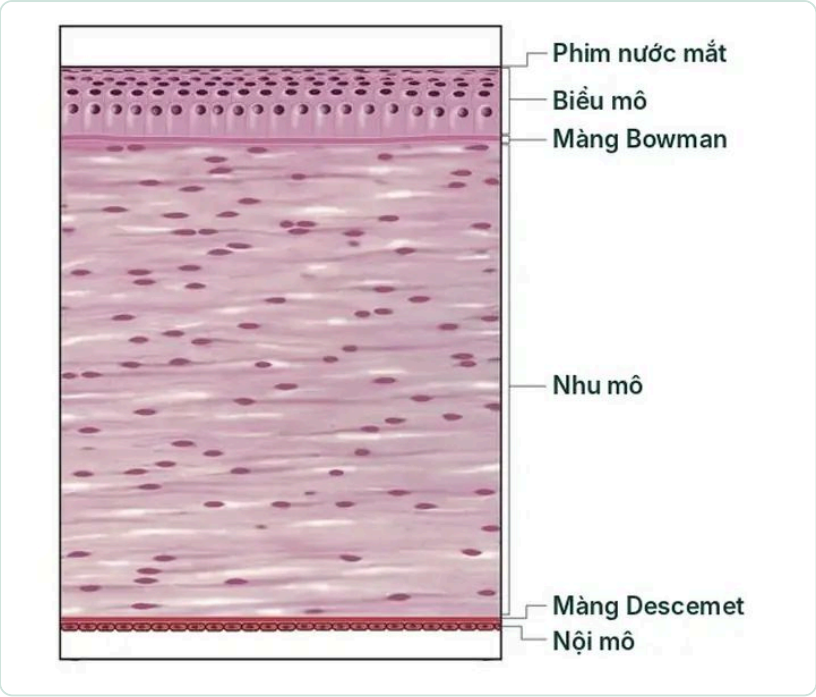
1. GIẢI PHẪU GIÁC MẠC

- Giác mạc là "cửa sổ" trong suốt ở phía trước nhãn cầu. Khi khám bằng **sinh hiển vi đèn khe**, khe sáng cắt qua giác mạc cho ta thấy rõ từng lớp.



Hình 3.1. Hình cắt lớp của giác mạc khi quan sát qua sinh hiển vi đèn khe.

- Giác mạc có **5 lớp**, từ ngoài vào trong:
  - **Biểu mô**
  - **Màng Bowman**
  - **Nhu mô**
  - **Màng Descemet**
  - **Nội mô**



Hình 3.2. Năm lớp của giác mạc trên tiêu bản mô học; nhu mô chiếm phần lớn bề dày.

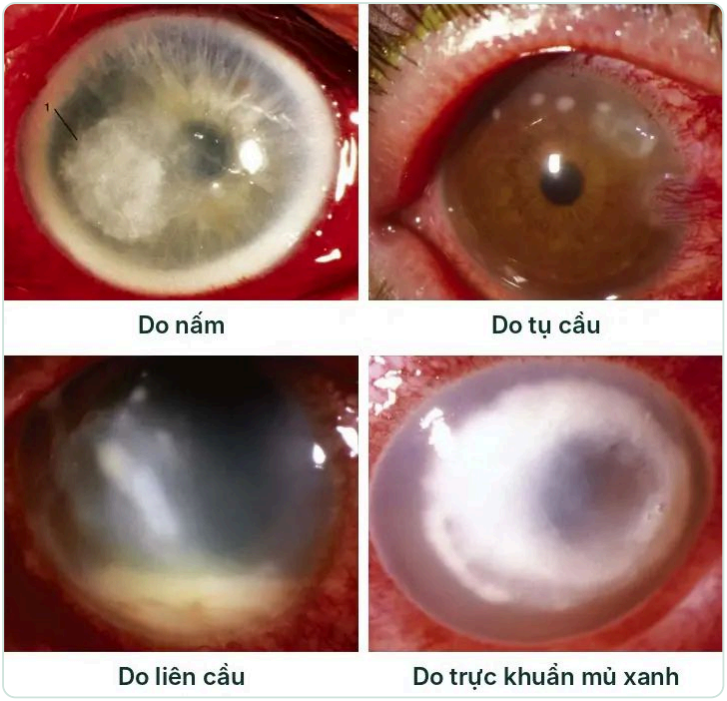
Mẹo nhớ thứ tự 5 lớp: "Bé Bơi Nhanh Dưới Nước" – **B**iểu mô, **B**owman, **N**hu mô, **D**escemet, **N**ội mô.

Vì sao loét giác mạc để lại hậu quả nặng? Lớp biểu mô tái tạo nhanh, xước nông sẽ lành mà không để lại dấu vết. Nhưng khi ổ loét ăn qua **màng Bowman vào nhu mô**, chỗ lành sẽ là **sẹo đục**. Sẹo nằm ở trung tâm thì che mất đường đi của ánh sáng → **giảm thị lực vĩnh viễn**.

2. ĐẠI CƯƠNG VÀ CƠ CHẾ BỆNH SINH

- Viêm loét giác mạc là **nguyên nhân đứng hàng thứ tư gây mù trên thế giới**.
- **Cơ chế bệnh sinh** gồm 3 bước nối tiếp:
  - **Bám dính:** tác nhân bám trên chỗ **biểu mô bị khuyết** (trầy xước, khô mắt, kính tiếp xúc...).
  - **Xâm lấn:** tác nhân **tăng số lượng và dàn trải**, diễn ra mạnh trong **2 ngày đầu**.
  - **Viêm và tổn thương mô:** tác nhân **tiết men hủy mô** → ổ loét lan rộng, sâu dần.

Hiểu nhanh: biểu mô lành lặn là "bức tường" bảo vệ. Hầu hết vi sinh vật **không tự xuyên qua được** biểu mô nguyên vẹn; chúng cần một **vết xước** để bám vào. Vì vậy, chấn thương nhỏ ở mắt và đeo kính tiếp xúc không đúng cách là những yếu tố nguy cơ hàng đầu.



Hình 3.3. Viêm loét giác mạc do các tác nhân khác nhau: mỗi tác nhân có một "dáng" ổ loét gợi ý.

3. VIÊM LOÉT GIÁC MẠC DO NẤM

Yếu tố nguy cơ

- **Kính tiếp xúc.**
- **Chấn thương, nhất là do thực vật** (cành cây, lá lúa...).
- **Lạm dụng corticoid.**
- Phẫu thuật: **LASIK, ghép giác mạc**.
- **Viêm bề mặt nhãn cầu mạn tính.**

Triệu chứng

- Đỏ; **đau nhức mắt, tăng về đêm**; nhìn mờ; chảy nước mắt; sợ ánh sáng.

Dấu chứng

- **Cương tụ kết mạc.**
- Thâm nhiễm, phù, nhuyễn giác mạc với hình ảnh đặc trưng:
  - **Bờ lông vũ** (bờ ổ loét tua tủa, không gọn).
  - **Sang thương vệ tinh** (các ổ nhỏ rải quanh ổ chính).
  - **Bề mặt gồ**, khô; có thể có **sắc tố**.
- **Mủ tiền phòng.**

> **Liên hệ thực tế:** người làm nông bị **lá lúa, cành cây** quẹt vào mắt, sau vài ngày mắt đỏ, đau nhức về đêm, ổ loét trắng bờ tua tủa → nghĩ ngay **nấm**.

4. VIÊM LOÉT GIÁC MẠC DO VI KHUẨN

Triệu chứng và dấu chứng

- **Triệu chứng:** đỏ, đau, nhìn mờ, chảy nước mắt, sợ ánh sáng.
- **Dấu chứng:**

    - **Cương tụ kết mạc.**
    - Thâm nhiễm **hình tròn / oval**, phù, nhuyễn giác mạc: **bờ gọn, rõ**; **bề mặt nhẵy, phẳng hoặc lõm**.
    - **Mủ tiền phòng.**
- Theo bảng thống kê trong bài giảng: **cầu khuẩn Gram (+) chiếm khoảng 29–53%**, **vi khuẩn Gram (–) khoảng 47–50%** số ca (riêng **Pseudomonas 3–33%**).

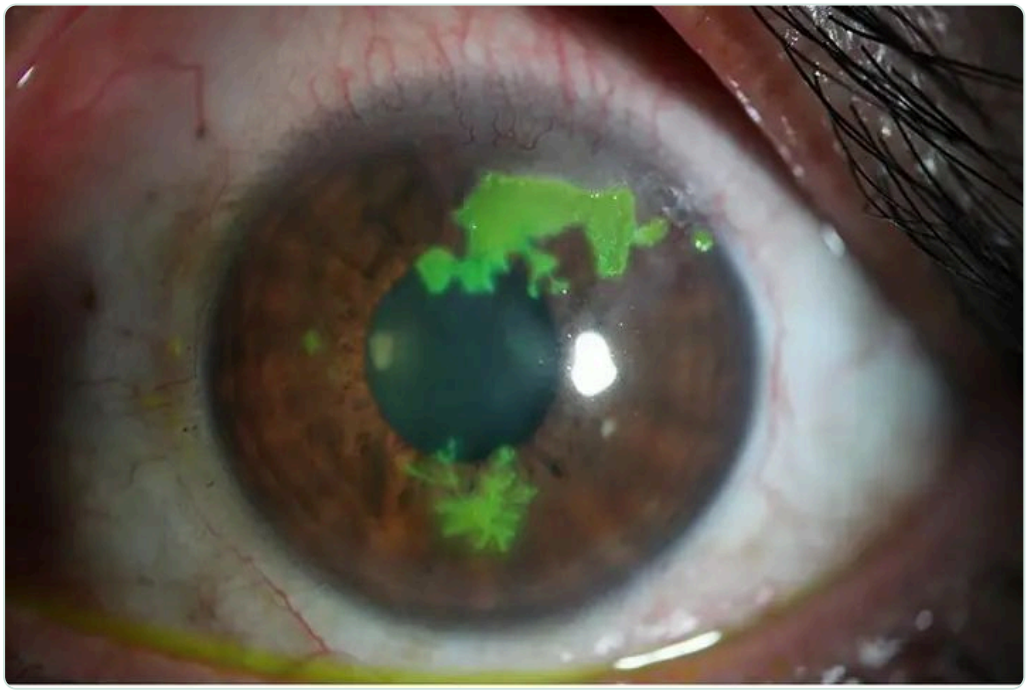
Các vi khuẩn thường gặp

Tác nhân	Đặc điểm
Staphylococci (tụ cầu)	**Gram (+) thường gặp nhất**. Thuận lợi khi **giác mạc đã có bệnh** (khô mắt, viêm giác mạc Herpes, viêm bờ mi, viêm kết giác mạc dị ứng...). **MRSA** gặp **sau phẫu thuật laser**. Tụ cầu coagulase (–) có ở **85% mi mắt người bình thường** → gây **nhiễm trùng cơ hội**
Streptococci (liên cầu)	Thuận lợi sau **chấn thương, viêm túi lệ**, nhiễm trùng bọng. **Diễn tiến nhanh, nhiều mủ, dễ thủng**
Pseudomonas (trực khuẩn mủ xanh)	**Gram (–) thường gặp nhất**. Liên quan **kính tiếp xúc**. **Diễn tiến rất nhanh, nhiều mủ, dễ thủng**

> **Cảnh báo:** người **đeo kính tiếp xúc** bị đau, đỏ một mắt → phải nghĩ tới **Pseudomonas**: ổ loét có thể lan rộng và **thủng giác mạc chỉ trong 1–2 ngày**. Tháo kính, chuyển chuyên khoa ngay.

5. VIÊM LOÉT GIÁC MẠC DO HSV

- **HSV-1:** vùng **hầu họng, mắt**. **HSV-2:** vùng **niệu dục**.
- Diễn tiến 3 giai đoạn:
    - **Nguyên phát:** lần nhiễm đầu, **có hoặc không có triệu chứng**.
    - **Tiềm ẩn:** virus "ngủ" trong **hạch thần kinh**.
    - **Tái hoạt:** khi **miễn dịch suy giảm** (sốt, stress, dùng corticoid...) → bệnh tái phát nhiều lần.



Hình 3.4. HSV: ổ loét hình cành cây bắt màu xanh khi nhuộm fluorescein.

- **Triệu chứng:** đỏ, nhìn mờ, chảy nước mắt, sợ ánh sáng, **ít đau**.

- **Dấu chứng:**
  - **Cương tụ kết mạc.**
  - Thâm nhiễm, phù, nhuyễn giác mạc **hình cành cây, hình bản đồ**.
  - **Giảm cảm giác giác mạc.**
  - Có thể có **mủ tiền phòng**.

Vì sao loét do HSV lại "ít đau"? Virus sống trong dây thần kinh và làm tổn thương các nhánh thần kinh cảm giác của giác mạc → **giác mạc giảm cảm giác**. Một ổ loét to mà bệnh nhân **ít đau** chính là gợi ý quan trọng của HSV.

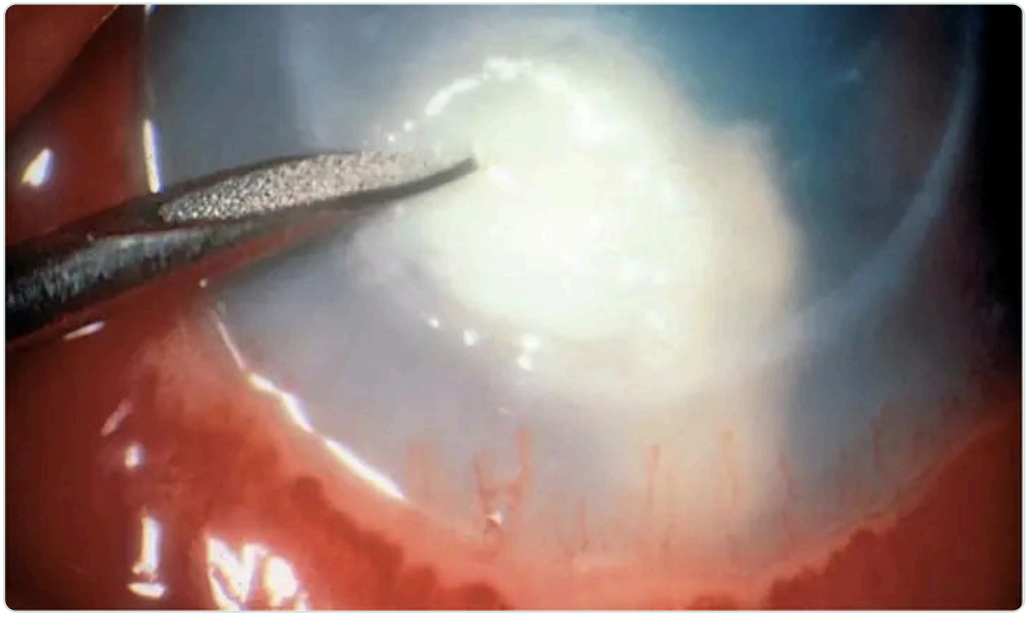
Lưu ý: không tự ý nhỏ thuốc có corticoid cho mắt đỏ chưa rõ nguyên nhân. Corticoid là yếu tố nguy cơ của **loét do nấm** và có thể làm **loét do HSV nặng lên**.

So sánh nhanh 3 tác nhân

Đặc điểm	Nấm	Vi khuẩn	HSV
Hoàn cảnh	Chấn thương thực vật, corticoid	Kính tiếp xúc, chấn thương, giác mạc có bệnh	Tái phát khi giảm miễn dịch
Đau	Đau nhức, **tăng về đêm**	Đau	**Ít đau**
Hình ổ loét	**Bờ lông vũ, ổ vệ tinh**, bề mặt gồ	Tròn/oval, **bờ gọn rõ**, bề mặt nhẵn	**Cành cây, bản đồ**
Dấu riêng	Có thể có sắc tố	Mủ nhiều, dễ thủng	**Giảm cảm giác giác mạc**

6. CHẨN ĐOÁN

- Dựa vào **lâm sàng** và **xét nghiệm: soi tươi, nuôi cấy, nhuộm Gram, PCR**.
- Bệnh phẩm được lấy bằng cách **cạo ổ loét** dưới kính hiển vi.



Hình 3.5. Cạo ổ loét giác mạc để lấy bệnh phẩm soi tươi, nhuộm và nuôi cấy.

- **Bắt buộc phải làm xét nghiệm vi sinh** khi:
  - Thâm nhiễm giác mạc **rộng, trung tâm, sâu**, có **nhuyễn giác mạc**.

- Nhiễm trùng **kéo dài** hoặc **không đáp ứng với kháng sinh phổ rộng**.
- Có **tiền căn phẫu thuật giác mạc**.
- Sang thương **không điển hình**, gợi ý **nấm, amíp hoặc mycobacterium**.
- Thâm nhiễm **đa ổ**.

> **Hiểu nhanh:** ổ loét nhỏ, ở rìa, điển hình vi khuẩn có thể điều trị kháng sinh phổ rộng trước. Còn ổ loét **nặng, khó, lạ** thì phải biết chính xác tác nhân để chọn đúng thuốc – đó là lý do xét nghiệm trở thành **bắt buộc**.

7. ĐIỀU TRỊ

- **Thuốc:** tại chỗ / toàn thân, **đặc hiệu theo tác nhân** (kháng sinh, kháng nấm, kháng virus).
- **Thủ thuật:**
  - **Dán keo:** bịt chỗ giác mạc mỏng hoặc thủng nhỏ.
  - **Tiêm thuốc vào nhu mô:** đưa thuốc tới sâu trong ổ loét.
  - **Rửa tiền phòng:** lấy bớt mủ trong tiền phòng.
- **Phẫu thuật:**
  - **Ghép màng ối:** giúp bề mặt giác mạc lành lại.
  - **Ghép giác mạc điều trị:** thay phần giác mạc nhiễm trùng không đáp ứng thuốc hoặc đã thủng.
  - **Múc nội nhãn:** khi nhiễm trùng lan khắp nhãn cầu, không thể bảo tồn.

> **Ghi nhớ cả bài:** viêm loét giác mạc là **cấp cứu nhãn khoa**. Nhận ra sớm qua **đau, đỏ, sợ sáng, nhìn mờ, ổ đục trên giác mạc**; đoán tác nhân qua **hoàn cảnh và hình dạng ổ loét**; chuyển chuyên khoa để làm xét nghiệm và điều trị đặc hiệu.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ bài giảng 3. Corneal Ulcer - Diagnosis & Treatment.pdf. Hình minh hoạ lấy từ bài giảng, nhãn đã dịch sang tiếng Việt. Đối chiếu bài giảng gốc khi cần chi tiết.

GIÁO TRÌNH MẮT · BÀI 4

BÀI 4 Đục thủy tinh thể

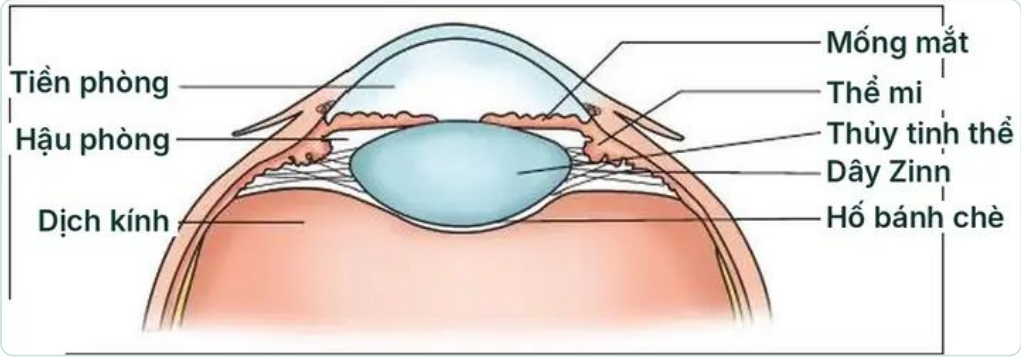
Biên soạn lại từ bài giảng 4. Cataract - Diagnosis & Treatment.pdf (23 trang) · Giải thích dễ hiểu, kèm 9 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. GIẢI PHẪU THỦY TINH THỂ
2. TỔNG QUAN VÀ YẾU TỐ NGUY CƠ
3. TRIỆU CHỨNG
4. CÁC HÌNH THÁI ĐỤC THỦY TINH THỂ
5. BIẾN CHỨNG
6. ĐIỀU TRỊ

Học xong bài này, bạn cần: trình bày được giải phẫu thủy tinh thể; nêu dịch tễ và yếu tố nguy cơ của đục thủy tinh thể; chẩn đoán được đục thủy tinh thể; nêu được các phương pháp điều trị.

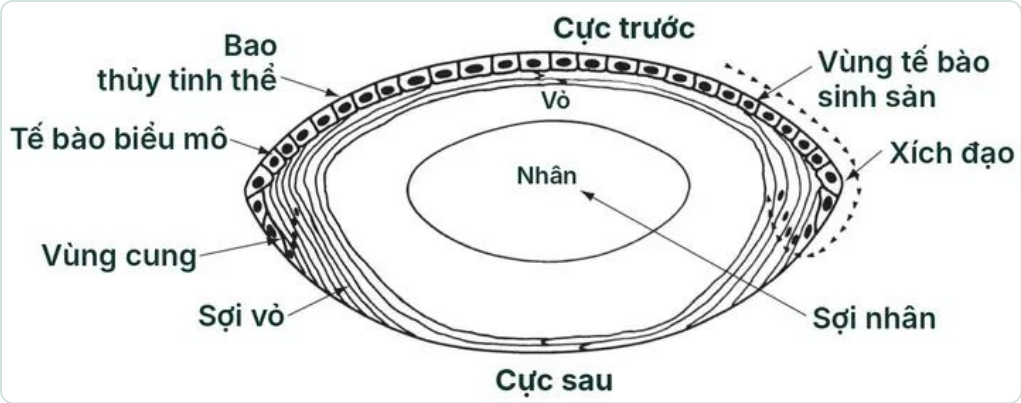
1. GIẢI PHẪU THỦY TINH THỂ

- Thủy tinh thể (TTT) nằm **ngay sau mống mắt**, trước dịch kính, được treo vào **thể mi** nhờ các **dây Zinn**.



Hình 4.1. Vị trí thủy tinh thể ở phần trước nhãn cầu.

- Đặc điểm:
  - Là một **thấu kính hội tụ, trong suốt**.
  - **Không có mạch máu, không có thần kinh**.
  - Công suất khúc xạ **khoảng +20D**.
- **3 phần chính: bao TTT**, **vỏ TTT**, **nhân TTT**.
  - **Bao TTT:** màng **bán thấm** với nước và chất điện giải.
  - **Biểu mô TTT** (nằm dưới bao trước): chuyển hóa và phân bào, **biệt hóa thành sợi TTT**.
  - **Vỏ và nhân TTT:** tạo thành từ các sợi TTT. **Sợi cũ bị nén dần vào trong** tạo thành nhân.



Hình 4.2. Cấu trúc thủy tinh thể: biểu mô ở vùng xích đạo sinh ra sợi mới; sợi cũ bị đẩy dần vào trung tâm thành nhân.

- **Vai trò:** duy trì **độ trong suốt**; **khúc xạ ánh sáng**; thực hiện **chức năng điều tiết** (thay đổi độ phồng để nhìn rõ ở gần).

> **Hiểu nhanh:** TTT giống như **củ hành**: lớp sợi mới liên tục được đắp thêm ở ngoài, lớp cũ bị ép vào giữa. Vì vậy tuổi càng cao, **nhân càng to, càng cứng và kém trong** – đó là lý do đục TTT gắn liền với tuổi già. "Đục thủy tinh thể" chính là khi thấu kính này **mất độ trong suốt**.

2. TỔNG QUAN VÀ YẾU TỐ NGUY CƠ

- Là **nguyên nhân hàng đầu gây mất thị lực** trên thế giới cũng như tại Việt Nam.
- Xuất hiện ở **mọi lứa tuổi**, đặc biệt **trên 50 tuổi**.
- **Nữ giới chiếm 2/3.**
- **Yếu tố nguy cơ:**
  - **Tuổi.**
  - **Sử dụng steroid kéo dài.**
  - **Hút thuốc lá.**
  - **Tiếp xúc tia UV.**
  - **Uống nhiều rượu bia.**
  - **Phẫu thuật nội nhãn.**
  - **Bệnh lý toàn thân** (đái tháo đường...).

3. TRIỆU CHỨNG

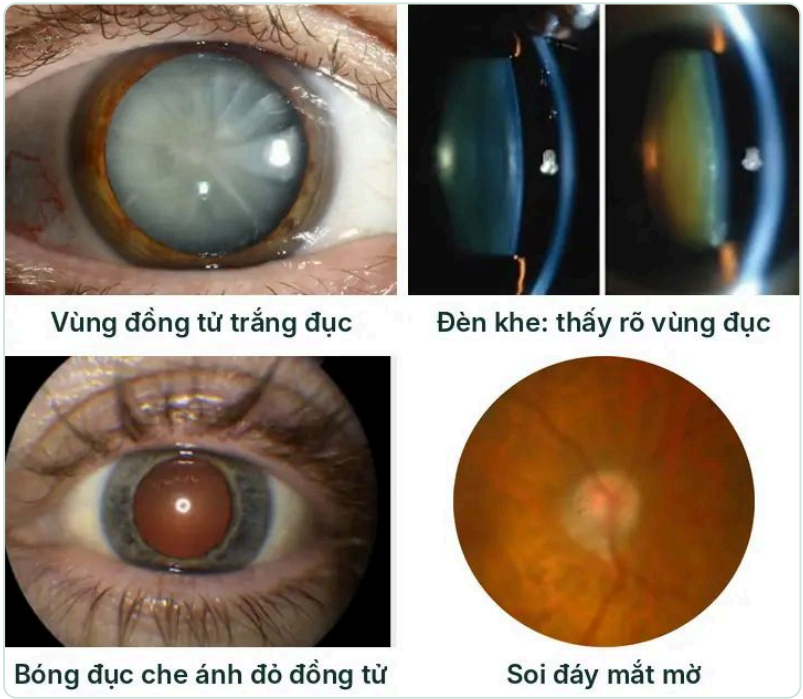
- **Nhìn mờ** tăng dần; mắt **không đỏ, không đau, không cộm xốn**.
- **Lóa mắt:** ánh sáng bị **tán xạ** khi đi qua vùng đục, nhất là khi nhìn đèn xe ban đêm.
- **Song thị một mắt:** vùng đục làm ánh sáng bị khúc xạ không đều, tạo hai ảnh; **che mắt kia vẫn thấy đôi**.
- **Cận thị giả:** nhân đục, cứng làm TTT **hội tụ mạnh hơn** → mắt trở nên "cận".



Hình 4.3. Đục thủy tinh thể làm cảnh vật mờ đi như nhìn qua màn sương.

Vì sao có người già bỗng đọc sách không cần kính lão? Đó là **cận thị giả** do đục nhân: TTT hội tụ mạnh hơn nên nhìn gần lại rõ, nhưng **nhìn xa thì mờ**. Đây không phải mắt "khỏe lại" mà là dấu hiệu đục TTT đang tiến triển.

Mẹo phân biệt: đỏ mắt + đau → nghĩ bệnh cấp (Bài 1). **Mờ từ từ, mắt trắng, không đau** ở người lớn tuổi → nghĩ **đục TTT** (hoặc glôcôm góc mở – Bài 5).



Hình 4.4. Khi khám: vùng đồng tử trắng đục, đèn khe thấy rõ vị trí đục, bóng đục che ánh đỏ đồng tử và đáy mắt nhìn mờ.

4. CÁC HÌNH THÁI ĐỤC THỦY TINH THỂ

Đục TTT do tuổi



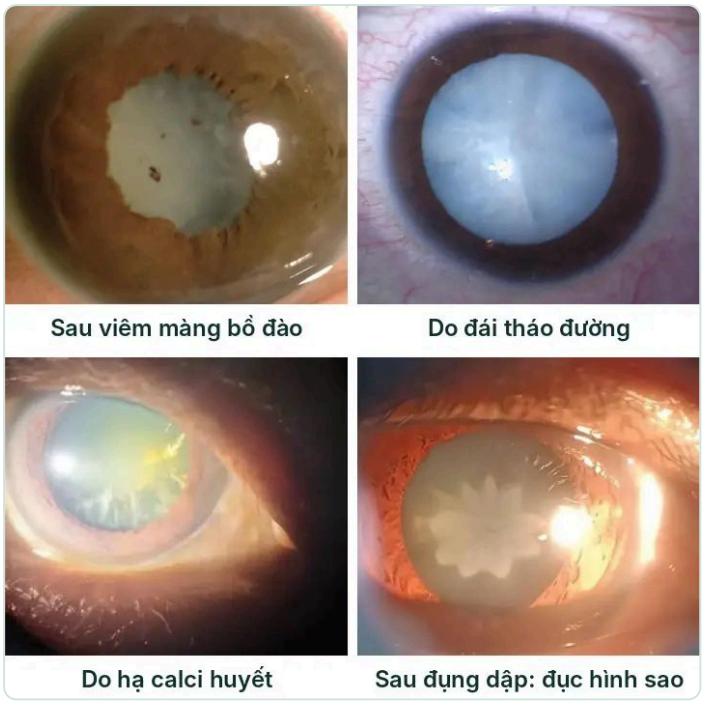
Hình 4.5. Ba hình thái đục do tuổi: đục nhân, đục vỏ và đục dưới bao sau.

Hình thái	Đặc điểm
Đục nhân	Tiến triển **chậm, 2 mắt**, có thể không cân đối; ảnh hưởng **thị lực nhìn xa**; **cận thị giả**
Đục vỏ	**Luôn luôn ở 2 mắt**, thường không cân xứng; **lóa mắt**; **dễ gây tăng nhãn áp thứ phát**
Đục dưới bao sau	Gặp ở **người trẻ tuổi**; **ra sáng nhìn mờ hơn trong tối**; phải khám dưới **đèn khe và đồng tử giãn**

> **Vì sao đục dưới bao sau lại "ra sáng mờ hơn"?** Vùng đục nằm ngay **trung tâm, phía sau**. Ra nắng, đồng tử co nhỏ lại, ánh sáng chỉ đi qua đúng vùng đục → mờ hẳn. Vào chỗ tối, đồng tử giãn, ánh sáng đi được qua phần ngoại vi còn trong → nhìn đỡ hơn.

Đục TTT do bệnh lý

- **Thứ phát sau viêm màng bồ đào (VMBĐ):**
  - Do **viêm kéo dài không kiểm soát**.
  - **Dính mống mắt vào mặt trước TTT** do sắc tố, xuất tiết.
  - **Phẫu thuật phức tạp, kết quả không cao.**
- **Do đái tháo đường:**
  - Người trẻ: **xuất hiện đột ngột, tiến triển nhanh**.
  - Người già: xuất hiện **sớm hơn** người không đái tháo đường, hình thái **giống đục TTT người già**.
- **Do hạ calci huyết:**
  - **Thường 2 mắt.**
  - **Chấm đục óng ánh** ở mặt trước và mặt sau TTT.
  - Có thể **ổn định** hoặc tiến triển thành **đục vỏ hoàn toàn**.



Hình 4.6. Đục thủy tinh thể do bệnh lý và do chấn thương.

Đục TTT do thuốc

- **Corticosteroid.**
- **Thuốc hướng tâm thần** (Phenothiazine).
- **Thuốc tim mạch** (Nifedipine, Methyldopa).

Đục TTT do chấn thương

- **Đụng dập nhãn cầu:**
  - Đục **nhanh hoặc âm ỉ**, **một phần hoặc toàn bộ**.
  - Dấu hiệu: **vòng Vossius** (vòng sắc tố mống mắt in lên mặt trước TTT), **đục hình sao**, **bán lệch TTT**.
- **Chấn thương xuyên:**
  - **Đục vỏ tại vị trí rách** bao, sau đó **diễn tiến đến đục toàn bộ**.
  - Đi kèm tổn thương khác: **đứt chân mống, dị vật nội nhãn**...
- **Chấn thương khác:** do **bức xạ**, **tia hồng ngoại**, **tia tử ngoại**, **hóa chất**, **điện**.

Đục TTT bẩm sinh

- **1 mắt hoặc cả 2 mắt.**
- **Yếu tố nguy cơ:** cha mẹ mắc **giang mai**, **đồng huyết thống**, **mẹ nhiễm Rubella trong 3 tháng đầu thai kỳ**.
- **Phẫu thuật càng sớm càng tốt, lý tưởng nhất là trước 3 tháng tuổi.**

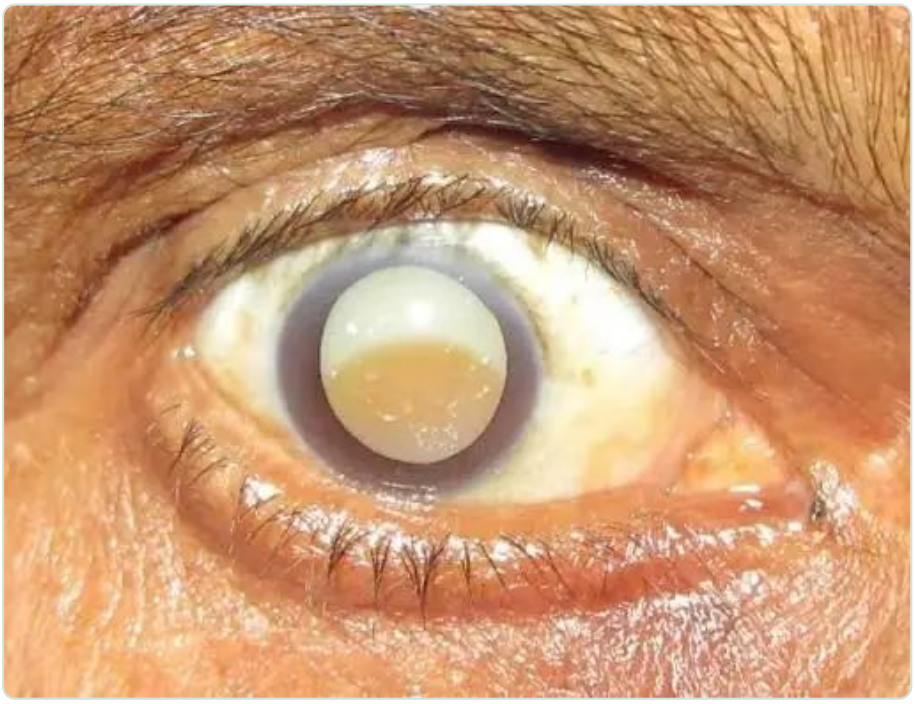


Hình 4.7. Đục thủy tinh thể bẩm sinh: đồng tử trắng; soi ánh đồng tử giúp phát hiện sớm.

> **Vì sao phải mổ sớm như vậy?** Những tháng đầu đời là giai đoạn não **học cách nhìn**. Nếu TTT đục che hình ảnh trong giai đoạn này, não không phát triển được chức năng thị giác cho mắt đó (**nhược thị**), mổ muộn thì dù TTT đã trong, mắt vẫn nhìn kém suốt đời.

5. BIẾN CHỨNG

- **Tăng nhãn áp thứ phát.**
- **Bao TTT vỡ** → nhân rơi vào **dịch kính** hoặc ra **tiền phòng** → **viêm màng bồ đào kèm tăng nhãn áp**.
- **Giảm thị lực nghiêm trọng.**



Hình 4.8. Đục thủy tinh thể để quá lâu: vỏ hóa lỏng, nhân chìm xuống dưới. Đây là giai đoạn dễ gây biến chứng.

Thông điệp cho bệnh nhân: đục TTT **không phải đợi "chín" mới mổ**. Để quá lâu, TTT căng phồng hoặc vỡ bao có thể gây **tăng nhãn áp, viêm màng bồ đào**, và cuộc mổ cũng khó hơn.

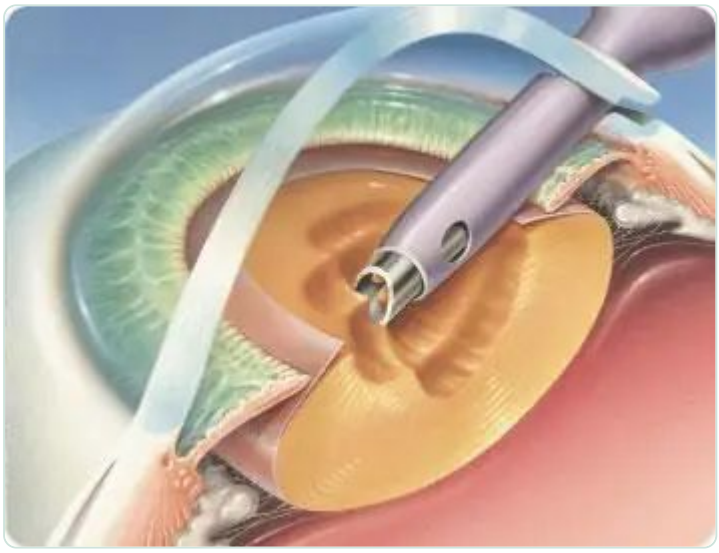
6. ĐIỀU TRỊ

Nội khoa

- Chỉ dùng ở **giai đoạn chưa có chỉ định phẫu thuật**: các thuốc nhỏ như **C. Kary Uni, C. Quinax, C. Catacol**...
- **"Giả cận thị"** → **đeo kính tạm thời**.
- Thuốc **không làm TTT đã đục trong trở lại**; điều trị triệt để là **phẫu thuật**.

Ngoại khoa

- **Phẫu thuật lấy TTT trong bao:** lấy toàn bộ TTT cùng với bao.
- **Phẫu thuật lấy TTT ngoài bao:** lấy nhân và vỏ, **giữ lại bao sau**.
- **Phẫu thuật tán nhuyễn TTT bằng siêu âm (Phaco):** qua **vết mổ nhỏ**, đầu siêu âm tán nhuyễn nhân rồi hút ra.
- Sau khi lấy TTT, thường **đặt thủy tinh thể nhân tạo** để thay cho công suất khoảng +20D đã mất.



Hình 4.9. Phaco: đầu siêu âm đưa qua vết mổ nhỏ để tán nhuyễn và hút thủy tinh thể đục.

Ghi nhớ cả bài: TTT là thấu kính **trong suốt, không mạch máu**, +20D. Đục TTT gây **mờ từ từ, không đỏ, không đau**, kèm lóa, song thị một mắt, cận thị giả. Ba hình thái do tuổi: **nhân – vỏ – dưới bao sau**. Điều trị triệt để là **phẫu thuật**, với trẻ bẩm sinh thì **mổ trước 3 tháng tuổi**.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ bài giảng 4. Cataract - Diagnosis & Treatment.pdf. Hình minh hoạ lấy từ bài giảng, nhãn đã dịch sang tiếng Việt. Đối chiếu bài giảng gốc khi cần chi tiết.

BÀI 5 Bệnh glaucoma

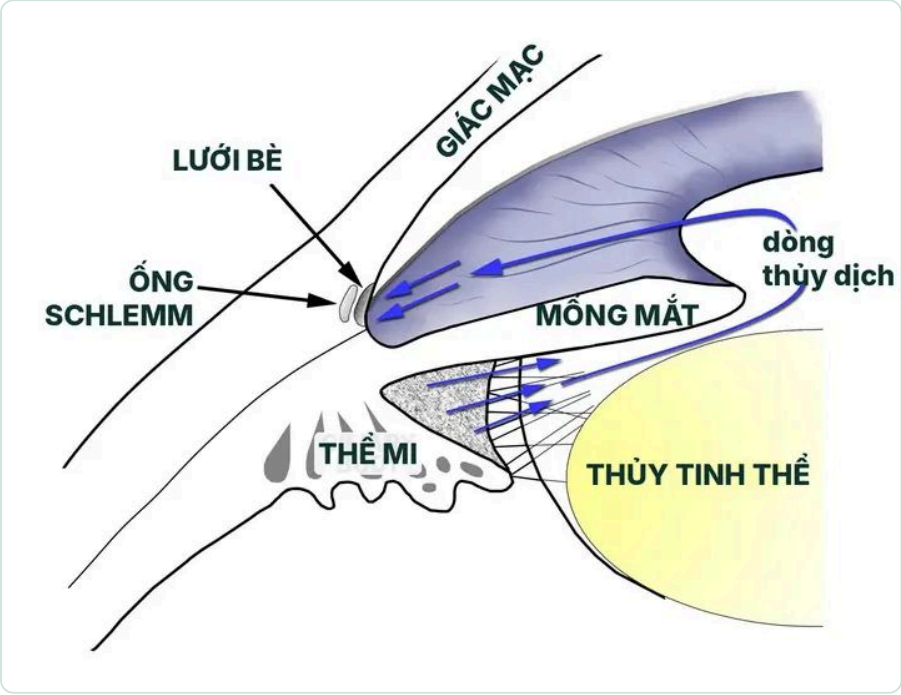
Biên soạn lại từ bài giảng 5. Glaucoma - Diagnosis & Treatment.pdf (19 trang) · Giải thích dễ hiểu, kèm 7 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. SINH LÝ THỦY DỊCH
2. NHÃN ÁP
3. ĐẠI CƯƠNG VÀ PHÂN LOẠI
4. GLAUCOMA NGUYÊN PHÁT GÓC ĐÓNG
5. GLAUCOMA NGUYÊN PHÁT GÓC MỞ
6. GLAUCOMA BẨM SINH

Học xong bài này, bạn cần: trình bày được triệu chứng lâm sàng của glaucoma góc đóng và góc mở; phát hiện các triệu chứng đặc trưng của glaucoma; nêu được các phương pháp điều trị.

1. SINH LÝ THỦY DỊCH

- **Sản xuất: biểu mô ở nếp thể mi**.
- **Lưu thông: hậu phòng → lỗ đồng tử → tiền phòng**.
- **Thoát lưu: góc tiền phòng → lưới bè → ống Schlemm → tĩnh mạch thượng củng mạc**.
- **Vai trò: tạo nhãn áp**, tham gia **quang học**, **nuôi dưỡng** (giác mạc, TTT là những mô không có mạch máu).



Hình 5.1. Đường đi của thủy dịch: sinh ra ở thể mi, qua đồng tử ra tiền phòng, thoát ở góc tiền phòng qua lưới bè vào ống Schlemm.

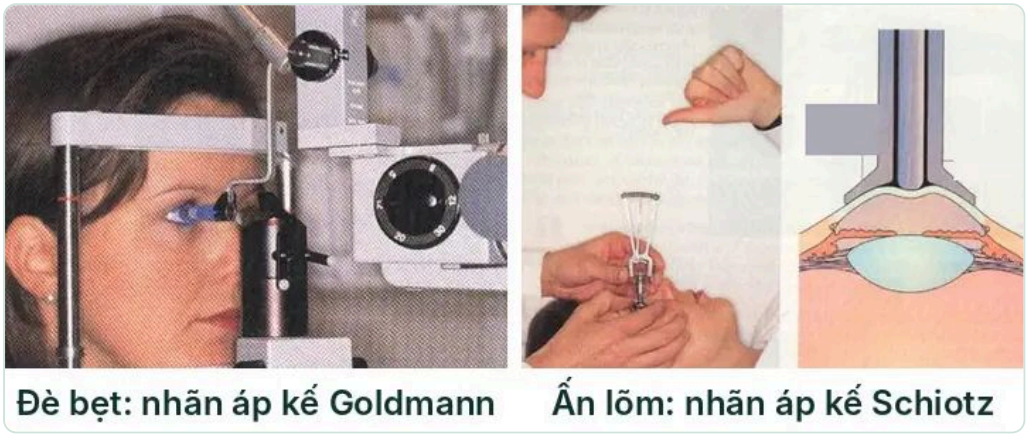
Hiểu nhanh: hãy hình dung mắt như một **bồn rửa có vòi và lỗ thoát**. **Thể mi là vòi nước**, liên tục chảy ra thủy dịch; **góc tiền phòng với lưới bè là lỗ thoát**. Nhãn áp chỉ tăng khi nước chảy vào nhiều hơn nước thoát ra – mà trên thực tế, thủ phạm thường là **lỗ thoát bị tắc**.

2. NHÃN ÁP

- **Công thức Goldmann: Pio = D × R + Pv**

- **Pio:** nhãn áp (**bình thường 10–21 mmHg**).
- **D:** tốc độ sản xuất thủy dịch.
- **R:** trở lưu thủy dịch (lỗ thoát khó hay dễ).
- **Pv:** áp lực tĩnh mạch thượng củng mạc.

- **Lưu ý lâm sàng:**
  - **Đa số tăng nhãn áp là do tăng R** (cản trở thoát lưu), không phải do sản xuất quá nhiều.
  - Nhãn áp **dao động trong ngày, thường cao vào nửa đêm / sáng sớm**.
  - Vì vậy **cần đo nhãn áp nhiều lần trong ngày**; một lần đo bình thường chưa loại trừ được bệnh.
- **Nhãn áp kế:**
  - Nguyên lý **đè bẹt**: nhãn áp kế **Goldmann**, **Maclakov**.
  - Nguyên lý **ấn lõm**: nhãn áp kế **Schiotz**.



Hình 5.2. Hai nguyên lý đo nhãn áp: đè bẹt (Goldmann gắn trên sinh hiển vi) và ấn lõm (Schiotz đặt trên giác mạc bệnh nhân nằm).

3. ĐẠI CƯƠNG VÀ PHÂN LOẠI

- Glaucoma là **nguyên nhân gây mù đứng hàng thứ 2** (theo bài giảng: **đứng sau đái tháo đường**).
- Toàn cầu: **> 66,8 triệu người mắc** (năm 2000).
- **Ba đặc điểm chung:**
  - **Tăng nhãn áp** quá mức chịu đựng của mắt.
  - **Thị thần kinh: lõm và teo gai thị.**
  - **Thị trường: bị tổn hại nghiêm trọng.**



Hình 5.3. Gai thị bình thường (mũi tên), gai thị lõm teo do glaucoma và thị trường bị thu hẹp.

> **Vì sao glaucoma đáng sợ hơn đục thủy tinh thể?** Đục TTT mổ xong là nhìn lại được. Còn glaucoma phá hủy **sợi thần kinh thị giác** – phần thị lực đã mất **không lấy lại được**. Điều trị chỉ giữ cho bệnh **không nặng thêm**, nên phát hiện sớm là quan trọng nhất.

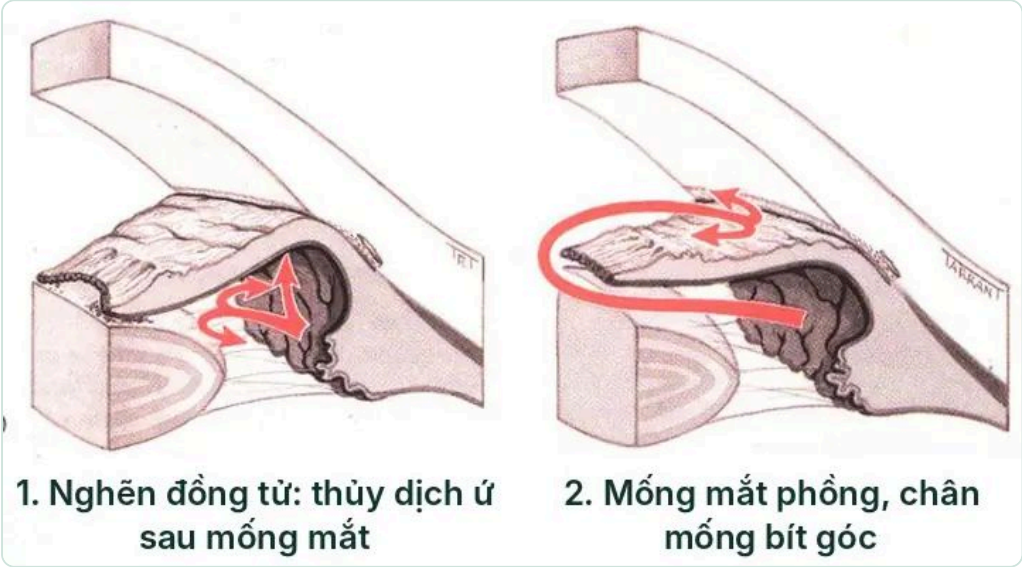
Loại	Đặc điểm
Nguyên phát	**Không kèm bệnh lý khác**; thường **bị 2 mắt**, có tính **di truyền**
Thứ phát	**Kèm bệnh mắt / toàn thân**, **do tác dụng thuốc**; thường **bị 1 mắt**
Bẩm sinh	Ở **sơ sinh**, do **bất thường góc tiền phòng**; sợ sáng, chảy nước mắt
Tuyệt đối	**Không đáp ứng điều trị**; **mất thị lực, đau nhức nhiều**

4. GLAUCOMA NGUYÊN PHÁT GÓC ĐÓNG

Dịch tễ và yếu tố nguy cơ

- **Chủng tộc:** da đen, **châu Á** (Mông Cổ, **Việt Nam**).
- **Giới: nữ >> nam**. **Tuổi:** lớn tuổi.
- **Cấu trúc mắt: tiền phòng nông, góc hẹp, viễn thị, trục nhãn cầu ngắn**.
- **Di truyền:** tiền căn gia đình có người mắc bệnh.
- **Yếu tố thúc đẩy cơn: căng thẳng (stress), lạnh, thuốc giãn đồng tử**.

Cơ chế



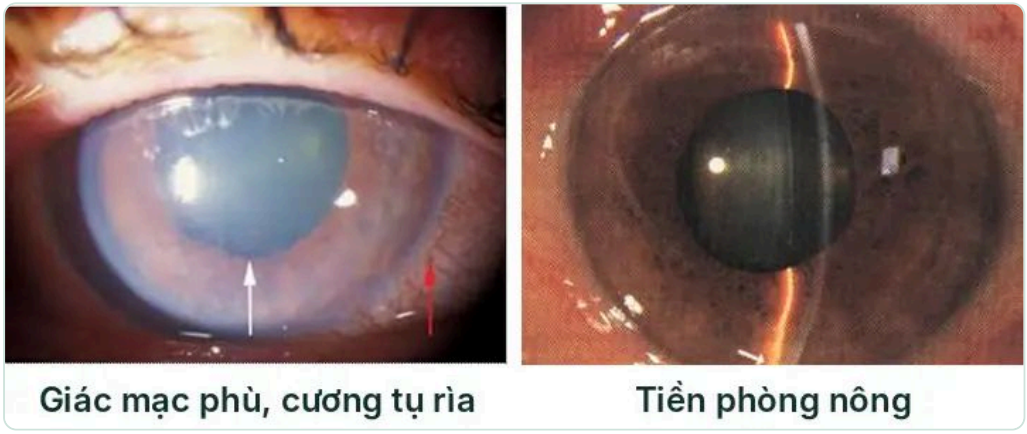
Hình 5.4. Cơ chế đóng góc: thủy dịch bị nghẽn ở đồng tử, ứ lại sau mống mắt, đẩy mống mắt phồng ra trước và bít góc tiền phòng.

- Ở mắt có **tiền phòng nông, góc hẹp**, mống mắt nằm rất sát TTT → thủy dịch khó đi qua lỗ đồng tử (**nghẽn đồng tử**).
- Thủy dịch **ứ lại ở hậu phòng**, đẩy mống mắt **phồng ra trước**.
- **Chân mống mắt áp vào lưới bè** → **góc tiền phòng đóng** → thủy dịch không thoát được → **nhãn áp tăng vọt**.

> **Vì sao thuốc giãn đồng tử, bóng tối, stress lại gây cơn?** Khi đồng tử giãn, mống mắt **co cụm dày lên ở chân mống**, đúng vị trí góc vốn đã hẹp → góc bị bít. Vì thế, với người có tiền phòng nông, **phải thận trọng khi nhỏ thuốc giãn đồng tử**.

Triệu chứng lâm sàng

- **Cơ năng:**
  - **Đỏ, đau, nhìn mờ.**
  - **Thấy quầng màu sắc** quanh bóng đèn.
  - **Buồn nôn và nôn ói**; hoa mắt.
- **Thực thể:**
  - **Giảm thị lực, nhãn áp cao.**
  - **Soi góc tiền phòng: góc đóng.**
  - **Kết mạc cương tụ rìa**; **giác mạc phù**; **tiền phòng nông**.
  - **Đồng tử giãn méo, phản xạ ánh sáng (–).**
  - **Gai thị cương tụ / lõm teo gai.**



Hình 5.5. Cơn glaucoma góc đóng cấp: giác mạc phù mờ, cương tụ rìa, đồng tử giãn; khe sáng cho thấy tiền phòng rất nông.

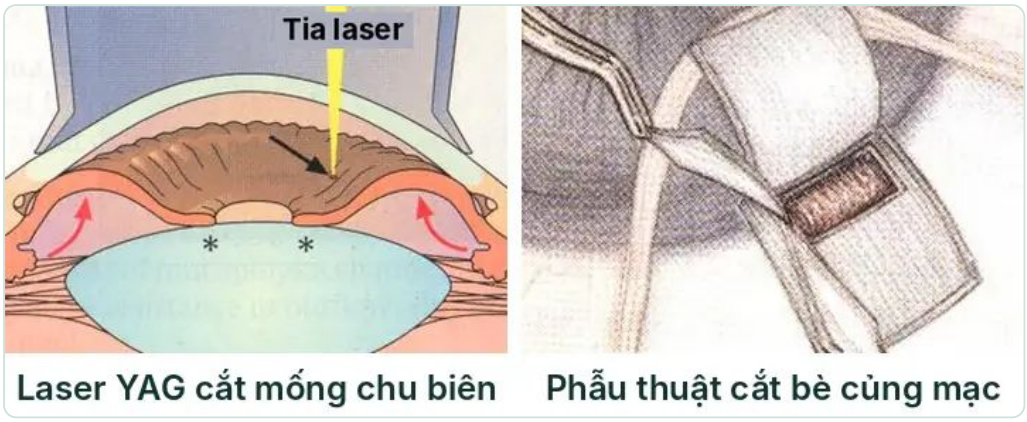
> **Vì sao thấy "quầng màu"?** Nhãn áp cao đẩy nước vào giác mạc làm **giác mạc phù**; ánh sáng đi qua giác mạc phù bị tán xạ thành **các vòng màu như cầu vồng** quanh bóng đèn. Nhãn áp quá cao còn làm thiếu máu cơ mống mắt → **đồng tử giãn, méo, mất phản xạ**.

Điều trị nội khoa

- **Mục tiêu: cắt cơn cấp**, **bảo vệ mắt còn lại**, điều trị **tạm thời chờ phẫu thuật**.
- **Toàn thân:**
  - **Thuốc ức chế men CA (CAIs)**: giảm sản xuất thủy dịch.
  - **Truyền tĩnh mạch đường ưu trương (Mannitol 20%)**: rút nước ra khỏi nhãn cầu.
  - **Giảm đau, an thần.**
- **Tại chỗ:**
  - **β-bloquant**, **α-agonist**: giảm sản xuất thủy dịch.
  - **Pilocarpin**: co đồng tử, kéo chân mống ra khỏi góc.
  - **Kháng viêm steroid.**

Điều trị ngoại khoa

- **Laser YAG cắt mống chu biên:** tạo một lỗ nhỏ ở chân mống mắt → thủy dịch đi tắt từ hậu phòng ra tiền phòng, mống mắt **xẹp xuống, góc mở lại**.
- **Phẫu thuật cắt bè củng mạc:** tạo một **đường thoát mới** cho thủy dịch ra dưới kết mạc.



Hình 5.6. Laser YAG cắt mống chu biên (mũi tên đỏ: thủy dịch đi tắt qua lỗ laser) và phẫu thuật cắt bè củng mạc.

> **Cảnh báo:** cơn glaucoma góc đóng cấp là **cấp cứu nhãn khoa**. Nhãn áp rất cao kéo dài vài ngày có thể làm **mất thị lực vĩnh viễn**. Hạ nhãn áp ngay, rồi chuyển chuyên khoa để làm laser hoặc phẫu thuật.

5. GLAUCOMA NGUYÊN PHÁT GÓC MỞ

Dịch tễ và yếu tố nguy cơ

- **Chủng tộc: da đen >> da trắng. Giới:** nữ >> nam.
- **Tuổi:** người lớn tuổi (**60–70%**; **15% người > 80 tuổi**).
- **Di truyền:** nguy cơ **gấp 5–6 lần** nếu có **người ruột thịt mắc bệnh**.
- **Cơ chế: trở ngại lưu thông thủy dịch ở vùng bè** (chưa rõ). Góc vẫn **mở**, nhưng "lưới lọc" thoát kém.
- **Yếu tố nguy cơ khác: nhãn áp khởi điểm cao**, **dao động trong ngày**, **bề dày giác mạc trung tâm mỏng**, **PEX** (hội chứng giả bong bao).

Triệu chứng lâm sàng

- **Cơ năng:**
  - **Xuất hiện âm thầm, tiến triển chậm.**
  - **Thường ở 2 mắt.**
  - **Mờ từ từ, không đỏ, không đau.**
- **Thực thể:**
  - Giảm thị lực; **nhãn áp cao, dao động**, tăng từng lúc.
  - **Soi góc tiền phòng: góc mở.**
  - **Soi đáy mắt: lõm teo gai**, mạch máu bị đẩy **về phía mũi**, **tỉ lệ lõm/đĩa (C/D) ≥ 0,5**.

> **Hiểu nhanh về C/D:** gai thị là chỗ các sợi thần kinh thị tập trung đi ra khỏi mắt; ở giữa có một chỗ lõm sinh lý. Khi sợi thần kinh chết dần, **phần lõm (C) rộng ra so với cả đĩa (D)**. C/D càng lớn, thần kinh thị càng bị tổn thương nhiều.

> **"Kẻ trộm thị lực thầm lặng":** góc mở không đau, không đỏ, mất thị trường từ **ngoại vi vào trung tâm** nên người bệnh không nhận ra cho tới giai đoạn muộn. Người **lớn tuổi, có người thân mắc glaucoma** nên được **đo nhãn áp và soi đáy mắt định kỳ**.

Điều trị

- **Nội khoa (chủ lực):**
  - **Lựa chọn đầu tay: Prostaglandins (Latanoprost) → hạ nhãn áp 30–50%.**
  - **Thuốc ức chế β: Timolol** – lưu ý bệnh nhân **hen suyễn, bệnh tim mạch** (thuốc nhỏ mắt vẫn ngấm vào toàn thân, gây co thắt phế quản, chậm nhịp tim).
  - **Cường α / CAIs:** phối hợp khi cần thiết.
- **Ngoại khoa:**
  - **Tạo hình vùng bè bằng laser Argon.**
  - **Phẫu thuật cắt bè củng mạc, đặt valve.**
  - Chỉ dùng khi **nội khoa kém hiệu quả** hoặc **bệnh nhân không tuân thủ** điều trị.

So sánh góc đóng cấp và góc mở

Đặc điểm	Góc đóng cấp	Góc mở
Khởi phát	**Đột ngột, thành cơn**	**Âm thầm, tiến triển chậm**
Triệu chứng	Đỏ, **đau dữ dội**, nhìn mờ, quầng màu, nôn	**Không đỏ, không đau**, mờ từ từ
Soi góc	**Đóng**	**Mở**
Tiền phòng	**Nông**	Bình thường
Đồng tử	**Giãn méo, PXAS (–)**	Bình thường
Điều trị chính	Cắt cơn bằng thuốc → **laser cắt mống chu biên / cắt bè**	**Nội khoa (Prostaglandin) là chủ lực**

6. GLAUCOMA BẨM SINH

- **Tam chứng kinh điển: sợ sáng, chảy nước mắt, co quắp mi.**
- **Thực thể: mắt to (buphthalmos), đục giác mạc, đường kính giác mạc > 10 mm.**
- **Bệnh sinh: bất thường màng Barkan**, bất thường cấu trúc góc tiền phòng.
- **Điều trị:** nội khoa **ít tác dụng**; **phẫu thuật mở bè (goniotomy) là chủ yếu.**



Hình 5.7. Glaucoma bẩm sinh: hai mắt to bất thường; đo đường kính giác mạc giúp chẩn đoán.

> **Vì sao mắt trẻ lại to ra?** Vỏ nhãn cầu của trẻ nhỏ **còn mềm, giãn được**. Nhãn áp cao kéo dài làm nhãn cầu **căng phồng như quả bóng** – điều này không xảy ra ở người lớn vì củng mạc đã cứng.

Ghi nhớ cả bài: thủy dịch **sinh ở thể mi, thoát ở góc tiền phòng**; nhãn áp bình thường **10–21 mmHg**, tăng chủ yếu do **tắc đường thoát**. Góc đóng: **cấp, đau, đỏ, nôn, đồng tử giãn méo** → cấp cứu. Góc mở: **âm thầm, không đau, C/D ≥ 0,5** → điều trị nội khoa lâu dài, **Prostaglandin đầu tay**. Tổn thương thị lực do glaucoma **không hồi phục**.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ bài giảng 5. Glaucoma - Diagnosis & Treatment.pdf. Hình minh hoạ lấy từ bài giảng, nhãn đã dịch sang tiếng Việt. Đối chiếu bài giảng gốc khi cần chi tiết.